

Etapa 2.2

Síntese Final das Traduções

Consolidação qualificada, decidida em comitê pela coordenação.

Produto da etapa

Compare o original, as traduções independentes e a T-12 antes de registrar a decisão final do comitê.

T1/T2 carregadas

T-12 enviada

SEÇÕES GERAIS

§ Instruções gerais apresentação do instrumento Apresentação do instrumento e instrução de que a avaliação é feita no nível da nota.	
ORIGINAL (INGLÊS) Provider Document Summarization Quality Instrument (PDSQI)-9 for Generative Artificial Intelligence This instrument is an adapted version of the Physician Documentation Quality Instrument (PDQI-9; Stetson et al., Appl Clin Inform, 2012, PMC3347480), originally developed to evaluate provider documentation quality. It has been redesigned to assess the summarization of provider documentation by large language models (LLMs) and renamed the Provider Documentation Quality and Summarization Instrument (PDSQI-9). The redesign process followed a semi-Delphi methodology, engaging experts in human factors, data science, and clinical medicine from the University of Wisconsin-Madison, University of Colorado-Denver, UW Health, and Epic Systems. The evaluation is performed at the note level for each criterion.	
TRADUÇÃO T1 Este documento é uma versão adaptada de um instrumento de qualidade médica (PDQI-9, Stetson e colaboradores, Appl Clin Inform, 2012, PMC3347480).	TRADUÇÃO T2 Instrumento de Qualidade de Resumo de Documentação por profissionais de saúde (PDSQI-9) para Inteligência Artificial Generativa Salvar rascunho

Originalmente desenvolvido para avaliar e documentar qualidade . Ele foi feito para sintetizar a documentação de vários modelos de linguagens (LLMs) e renomeado de fornecedor de documento de qualidade resumido (PDSQI-9). O processo segue o mesmo método Delphi envolvendo a fatores de tradução human, dados científicos e clínicos da universidade de Wisconsin-Madison, universidade don Colorado-Denver, UW saúde , sistema épico . A evolução é avaliada pela nota de cada critério Dificuldade: média · Equivalências: Semântica, Idiomática, Experiencial	Este instrumento é uma versão adaptada do Physician Documentation Quality Instrument (PDQI-9; Stetson et al., Appl Clin Inform, 2012, PMC3347480), originalmente desenvolvido para avaliar a qualidade da documentação do profissional. Ele foi reformulado para avaliar a sumarização dessa documentação por modelos de linguagem ampla (LLMs) e renomeado como Provider Documentation Quality and Summarization Instrument (PDSQI-9). O processo de reformulação seguiu uma metodologia semi-Delphi, envolvendo especialistas fatores humanos, ciência de dados e medicina clínica da Universidade de Wisconsin-Madison, Universidade do Colorado-Denver, UW Health e Epic Systems. A avaliação é realizada em nível de nota para cada critério. Dificuldade: média · Equivalências: Experiencial
--	---

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

Instrumento de Avaliação da Qualidade de Sumarização do Profissional (PDSQI-9) para a Inteligência Artificial Generativa.

Este instrumento é uma versão adaptada do Instrumento de Qualidade da Documentação Médica - Physician Documentation Quality Instrument - (PDQI-9; Stetson et al., Appl Clin Inform, 2012, PMC3347480), originalmente desenvolvido para avaliar a qualidade da documentação do profissional da saúde. Este foi reformulado para analisar a sumarização de documentos realizada por modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs), sendo renomeado como Provider Documentation Quality and Summarization Instrument (PDSQI-9). O processo de reformulação seguiu uma metodologia semi-Delphi, envolvendo especialistas em fatores humanos, ciência de dados e medicina clínica das Universidades de Wisconsin-Madison, do Colorado-Denver, da UW Health e da Epic Systems. A avaliação é conduzida pelas notas obtidas em cada critério.

Decisão: O título do documento não foi traduzido em T1. A tradução correta de "Provider" seria "fornecedor". Neste caso, o profissional responsável pela documentação. O título per se não indica nenhuma especificação relacionada à área da saúde, por isso esta relação foi descartada nesta versão. De modo geral, a tradução em T2 está mais completa, considerando cada sentença do texto, mas fica muito ao pé da letra e pode ser melhorada considerando o contexto. As alterações foram feitas considerando esta última razão.

SÍNTESE FINAL - TITULO

Título final qualificado pelo comitê.

SÍNTESE FINAL - DESCRIÇÃO

Descrição final qualificada pelo comitê.



Nota sobre "asserção"

definição de termo

Definição de asserção como afirmação que pode ter uma ou mais frases.

ORIGINAL (INGLÊS)

*An assertion is a statement that can be single or multiple sentences.

TRADUÇÃO T1

A afirmação é um declaração que pode ter uma ou múltiplas frases.

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** Semântica, Experiencial

TRADUÇÃO T2

Uma asserção é uma declaração que pode ser frases simples ou múltiplas.

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

*Uma afirmação é uma declaração que pode ser constituída de frases únicas ou múltiplas.

Decisão: A tradução em T1 se afasta do significado de "can be". A tradução em T2 se aproxima mais, mas ainda está muito ao pé da letra e também se afasta do significado de "single". Quando consideramos a gramática do português brasileiro, podemos fazer algumas adaptações para tornar as sentenças mais coesas.

SÍNTESE FINAL (T-12F)

Redação final qualificada pelo comitê.

OBSERVAÇÕES

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

§ Sumarização extrativa

definição (antecede o item 2)

Seleção verbatim de trechos da fonte, sem alterar a redação.

ORIGINAL (INGLÊS)

Extraction-based summarization involves selecting and pulling exact phrases or sentences directly from the original text without altering the wording. The focus is on identifying the most important parts of the text and reproducing them verbatim to form the summary.

For example, in a clinical context, if the original text states, "the patient experienced shortness of breath, had an elevated white blood cell count, and showed a right lower lobe infiltrate on a chest X-ray," an extraction model would select and present these same sentences as the summary. There would be no attempt to infer or rephrase the content—just a selection of key details directly from the source.

TRADUÇÃO T1

Extrações baseadas em resumos envolvem seleções retiradas de frases ou sentenças retiradas do texto original sem alterar o significado . O foco é identificar as partes mais importantes do texto e reproduzir o parágrafo do resumo

Por exemplo no contexto clínico se o texto original diz . "O paciente que experimentou

TRADUÇÃO T2

A sumarização baseada em extração envolve selecionar e extrair frases ou sentenças exatas diretamente do texto original, sem alterar a redação. O foco está em identificar as partes mais importantes do texto e reproduzi-las literalmente para formar o resumo.

Por exemplo, no contexto clínico, se o texto

falta de ar teve elevada contagem de glóbulos brancos e mostrou um infiltrado no lobo direito do pulmão no Raio X" a extração pode ser selecionada para mesma sentença como um resumo.

Lá pode não ter havido tentativa de alterar ou refazer a sentença do conteúdo Apenas a seleção dos pontos chaves diretamente do assunto

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Experiencial

original afirma: "o paciente apresentou falta de ar, uma elevada contagem de glóbulos brancos e infiltrado no lobo inferior direito em uma radiografia de tórax", um modelo de extração selecionaria e apresentaria essas mesmas frases como resumo. Não haveria nenhuma tentativa de inferir ou reformular o conteúdo — apenas uma seleção de detalhes-chave diretamente da fonte.

Dificuldade: média · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

A sumarização baseada em extração envolve a seleção e extração de frases ou sentenças exatas, diretamente do texto original, sem alterar sua redação. O foco está em identificar as partes mais importantes do texto e reproduzi-las literalmente, para formar o resumo.

Por exemplo, em um contexto clínico, se o texto original afirmar: "O paciente experienciou falta de ar, tinha uma contagem elevada de leucócitos e apresentou um infiltrado no lobo inferior direito na radiografia de tórax", um modelo de extração selecionaria e apresentaria essas mesmas frases como resumo. Não haveria nenhuma tentativa de inferir ou reformular o conteúdo - apenas uma seleção dos detalhes-chave, diretamente da fonte.

Decisão: A tradução em T1 está muito simples, deixando alguns pequenos detalhes do texto original de fora, encurtando algumas expressões. Foram feitas pequenas alterações de concordância na tradução de T2, que mais se aproximava do original. Exemplos são o uso de substantivo ao invés de verbo em "seleção e extração" e a tradução de "experienced" como "experienciou".

SÍNTESE FINAL (T-12F)

Redação final qualificada pelo comitê.

OBSERVAÇÕES

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

§

Sumarização abstrativa

definição (antecede o item 8)

Paráfrase e síntese da informação em novas frases.

ORIGINAL (INGLÊS)

Abstraction-based summarization goes beyond simply extracting exact phrases or sentences from the original text. Instead, it involves paraphrasing and synthesizing the information to produce new sentences that capture the core meaning. This is similar to how a human might read a passage and then restate the key ideas in their own words.

For example, in a clinical context, instead of listing individual test results and medications (e.g., "the patient had an HbA1c of 9.2%, was prescribed metformin, and reported not following dietary recommendations"), an abstraction model might summarize this information as, "the patient has poorly controlled diabetes due to suboptimal adherence to treatment and lifestyle changes." This approach provides a synthesized understanding of the patient's overall condition rather than just enumerating discrete data points.

To evaluate abstraction, you should assess how well the summary captures the essence of the original content, whether the paraphrased statements are accurate, and whether the model is able to infer higher-level concepts from specific details provided in the source text.

TRADUÇÃO T1

Artigos-baseados em resumos vão além de simples extrações de frases ou sentenças do texto original. Ao invés isto envolve captura do real significado. Isto é parecido como o humano tem o poder de ler a mensagem e reformular os pontos chaves da ideia com suas próprias palavras .

Por exemplo, no contexto clinico, em vez de listar resultados de testes individuais e medicamentos (ex. "m o paciente teve HbA1 de 9,2%, foi prescrito metiformina, e relatado não seguir as recomendações de dieta"), no modelo de artigo pode ser resumido a

TRADUÇÃO T2

O resumo baseado em abstração vai além da simples extração de frases ou sentenças exatas do texto original. Em vez disso, envolve parafrasear e sintetizar as informações para produzir novas frases que capturem o significado principal. Isso é semelhante à forma como um ser humano leria um trecho e então reproduziria as ideias principais com suas próprias palavras.

Por exemplo, em um contexto clínico, em vez de listar resultados de testes e medicamentos individualmente (como "o paciente apresentava HbA1c de 9,2%, recebeu

informação como , "o paciente teve pouco controle da diabetes devido a pequena aderência ao tratamento e mudanças do estilo de vida" Esta apresentação fornece um entendimento sintetizado do paciente de toda sua condição ou invés de enumerar detalhes dos pontos.

Para avaliar artigos, você deve seguir como o resumo captura a essência do texto original, se a informação foi parafraseada são necessários e se o modelo é capaz de ter um alto nível no conceito de detalhes específicos provenientes do assunto do texto

Dificuldade: alta · **Equivalências:** Experiencial, Conceitual

prescrição de metformina e relatou não seguir as recomendações de dieta"), um modelo de abstração poderia resumir essas informações como: "o paciente apresenta diabetes mal controlado devido à adesão insuficiente ao tratamento e às mudanças no estilo de vida". Essa abordagem proporciona uma compreensão sintetizada da condição geral do paciente, ao invés de apenas enumerar dados isolados.

Para avaliar a abstração, deve-se analisar quão bem o resumo captura a essência do conteúdo original, se as afirmações parafraseadas são precisas e se o modelo é capaz de inferir conceitos de nível superior a partir de detalhes específicos fornecidos no texto de origem.

Dificuldade: média · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

A sumarização baseada em abstração vai além da simples extração de frases ou expressões exatas do texto original. Em vez disso, envolve parafrasear e sintetizar as informações para produzir novas frases que capturem o significado essencial. Isso é semelhante à maneira como um ser humano leria uma passagem e, em seguida, reformularia as ideias-chave com suas próprias palavras.

Por exemplo, em um contexto clínico, em vez de listar resultados de exames e medicamentos individualmente (por exemplo, "o paciente apresentou HbA1c de 9,2%, recebeu prescrição de metformina e relatou não estar seguindo as recomendações alimentares"), um modelo de abstração poderia resumir essas informações da seguinte forma: "o paciente apresenta diabetes mal controlada devido à adesão insuficiente ao tratamento e às mudanças no estilo de vida". Essa abordagem proporciona uma compreensão sintetizada do quadro geral do paciente, em vez de apenas enumerar entradas de dados isoladas.

Para avaliar a abstração, você deve analisar se o resumo captura bem a essência do conteúdo original, se as afirmações parafraseadas são precisas e se o modelo é capaz de inferir conceitos de nível superior a partir de detalhes específicos fornecidos no texto de origem.

Decisão: O uso de "resumo" como tradução de "summarization" é equivocado. A sumarização é usada para criar resumos, mas não é o resumo em si. "Core meaning" como "significado principal" também pode ter o sentido distorcido, uma vez que confere destaque, mas não necessariamente coloca o significado em questão na base do conceito. "essencial" reflete melhor essa relevância.

SÍNTESE FINAL (T-12F)

Redação final qualificada pelo comitê.

OBSERVAÇÕES

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

ITENS DO PDSQI-9**1****Cited**

As citações que ligam afirmações às notas de origem estão presentes e são apropriadas.

ORIGINAL (INGLÊS)

1. Are citations present and appropriate?

1 (Not at All): Multiple incorrect citations OR No citations provided

2: One citation incorrect OR citations grouped together and not with individual assertions

3: Citations correct but some assertions missing a citation

4: Every assertion correctly cited with some relevance prioritization

5 (Extremely): Every assertion is correctly cited and prioritized by relevance

TRADUÇÃO T1

1. São citação presentes e apropriadas ?

1. (não em tudo): Multiplas citações incorretas
OU citações não fornecidas

2. Uma citação incorreta OU citações
agrupadas juntas e não com afirmação
individual

TRADUÇÃO T2

1. As citações estão presentes e são
adequadas?

1 (De jeito nenhum): Múltiplas citações
incorretas OU Nenhuma citação fornecida

2: Uma citação incorreta OU citações
agrupadas e não como afirmações individuais

3.Citação correta mas algumas afirmações perderam a afirmação.

4. Todas afirmação citada com alguma relevancia de priorização

5. (extrema): Toda afirmação citada corretamente e priorizada pela relevancia.

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Experiencial

3: Citações corretas, mas algumas afirmações faltam citação

4: Todas as afirmações citadas corretamente, com alguma priorização por relevância

5 (Extremamente): Todas as afirmações citadas corretamente e priorizadas por relevância

Dificuldade: baixa · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

1. As citações estão presentes e são adequadas?

- 1 (De modo algum): Múltiplas citações incorretas OU Nenhuma citação fornecida
- 2 Uma citação incorreta OU citações agrupadas e sem afirmações individuais
- 3 Citações corretas, mas algumas afirmações sem citação
- 4 Cada afirmação citada corretamente, com alguma priorização correta de relevância
- 5 (Extremamente) Todas as afirmações estão corretamente citadas e priorizadas por relevância

Decisão: Pequenos ajustes de concordância em T2, T1 foi o que mais se diferiu.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

2**Accurate**

O resumo é verídico e livre de informação incorreta (fabricação ou falsificação).

ORIGINAL (INGLÊS)

2. Is the summary accurate in extraction (extractive summarization)?

a. The summary is true and free of incorrect information. (Example: Falsification – the provider states the last surveillance study was negative for active cancer, but the LLM summarizes the patient still has active disease.)

b. Incorrect Information can be a result of fabrication or falsification

i. Fabrication is when the response contains entirely made-up information or data and includes plausible but non-existent facts in the summary

ii. Falsification is when the response contains distorted information and includes changing critical details of facts, so they are no longer true from the source notes

iii. Examples of problematic assertions: It's not in the note, it was correct at one point but not at the time of summarization, a given assertion was changed to a different status (given symptoms of COVID but patient ended up not having COVID; however, LLM generates COVID as a diagnosis).

c. Something can be an incorrect statement by the provider in the note (not clinically plausible) but if the LLM summarizes the same statement from the provider then it's NOT a fabrication or falsification.

1 (Not at All): Multiple major errors with overt falsifications or fabrications

2: A major error in assertion occurs with an overt falsification or fabrication

3: At least one assertion contains a misalignment that is stated from a source note but the wrong context, including incorrect specificity in diagnosis or treatment

4: At least one assertion is misaligned to the provider's source or timing but still factual in diagnosis, treatment, etc.

5 (Extremely): All assertions can be traced back to the notes

TRADUÇÃO T1

2. O resumo na extração é necessário (extração resumida) ?

a. O resumo é verdadeiro e livre de informações incorretas (Exemplo: Falsificação - O provedor do ultimo estudo de vigilancia foi negativo para cancer, mas o LLM resumiu que o paciente ainda tem cancer)

b. informação incorreta pode ser resultado da fabricação ou falsificação

i. Fabricação é quando a resposta contem todas informações e dados plausíveis mas não existem os fatos no resumo.

ii. Falsificação é quando a resposta contem distorções na informação e inclui mudanças criticas nos detalhes e fatos , então eles não estão longe da verdade do assunto.

iii. Exemplo de afirmação problemática: Isto poden não ser notado, isto foi correto por um ponto mas não no momento do resumo, a afirmação entregue foi mudada para um status diferente (Sintomas de COVID mas paciente morreram sem ter COVID; contudo , LLM gerou o diagnóstico de COVID)

c. Algumas podem ter declarações incorretas

TRADUÇÃO T2

2. O resumo é preciso na extração (resumo extrativo)?

a. O resumo é verdadeiro e livre de informações incorretas. (Exemplo: Falsificação – o profissional afirma que o último estudo foi negativo para câncer ativo, mas o LLM resume que o paciente ainda tem doença ativa.)

b. Informações incorretas podem resultar de fabricação ou falsificação.

i. Fabricação ocorre quando a resposta contém informações ou dados totalmente inventados e inclui fatos plausíveis, porém inexistentes, no resumo.

ii. Falsificação ocorre quando a resposta contém informações distorcidas e inclui a alteração de detalhes críticos dos fatos, de modo que elas não são mais verdadeiras em relação às notas de origem.

iii. Exemplos de afirmações problemáticas: Não está na nota, estava correta em determinado momento, mas não no momento da elaboração do resumo, uma dada afirmação cujo status foi alterado (sintomas sugestivos de COVID, mas o paciente terminou não tendo COVID; no entanto, o LLM

fornecidas da nota (não são clinicamente plausíveis) mas se a LLM resumir a mesma declaração do fornecedor não é fabricação ou falsificação.

1. (Não para todos); Múltiplos erros maiores com falsificação e fabricação
- 2: o maior erro na afirmativa ocorre na afirmação e fabricação
- 3: A última afirmação contém a mistura de declaração do assunto mas no contexto errado , incluindo especificação incorreta no diagnóstico e tratamento
- 4: A última afirmação é misturada para fornecer assunto ou tempo mas continua real ao diagnóstico e tratamento e etc .
- 5: (extrema): Toda afirmação pode ser retirada da nota

Dificuldade: alta · **Equivalências:** Semântica, Conceitual

gera COVID como diagnóstico).

c. Uma afirmação feita pelo profissional de saúde na nota pode estar incorreta (cl clinicamente implausível); contudo, se o LLM resume essa mesma afirmação do profissional, isso NÃO constitui fabricação ou falsificação.

- 1 (De forma alguma): Múltiplos erros graves com falsificações ou fabricações evidentes.
- 2: Ocorre um erro grave de afirmação envolvendo falsificação ou fabricação evidente.
- 3: Pelo menos uma afirmação apresenta uma divergência em relação à nota de origem (ex.: contexto incorreto, incluindo especificidade errônea no diagnóstico ou tratamento).
- 4: Pelo menos uma afirmação diverge da fonte ou do momento temporal indicado pelo profissional, mas permanece correta quanto aos fatos (diagnóstico, tratamento, etc.).
- 5 (Totalmente): Todas as afirmações podem ser rastreadas até as notas originais.

Dificuldade: alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

2. O resumo é preciso na extração (sumarização extrativa)?

- a. O resumo é verdadeiro e livre de informações incorretas. (Exemplo: Falsificação – o profissional de saúde afirma que o último estudo de vigilância foi negativo para câncer ativo, mas o LLM resume que o paciente ainda apresenta doença ativa.)
- b. Informações incorretas podem ser resultado de invenção ou falsificação
 - i. Invenção é quando a resposta contém informações ou dados inteiramente inventados e inclui fatos plausíveis, mas inexistentes, no resumo
 - ii. Falsificação é quando a resposta contém informações distorcidas e inclui a alteração de detalhes críticos dos fatos, de modo que eles não são mais verdadeiros em relação às anotações da fonte
 - iii. Exemplos de afirmações problemáticas: Não consta na anotação; estava correto em determinado momento, mas não no momento da sumarização; uma determinada afirmação foi alterada para um status diferente (apresentava sintomas de COVID, mas o paciente acabou não tendo COVID; no entanto, o LLM gera COVID como diagnóstico).
- c. Uma afirmação pode ser incorreta por parte do profissional na nota original (cl clinicamente implausível), mas se o LLM resumir a mesma afirmação, então NÃO se trata de uma invenção ou

falsificação.

1 (De modo algum): Múltiplos erros graves com falsificações ou invenções evidentes

2: Ocorre um erro grave na afirmação, com uma falsificação ou invenção evidente

3: Pelo menos uma afirmação contém um deslocamento que é mencionado em uma nota da fonte, mas no contexto errado, incluindo especificidade incorreta no diagnóstico ou no tratamento

4: Pelo menos uma afirmação diverge da fonte ou do momento temporal indicado pelo profissional, mas permanece correta quanto aos fatos (diagnóstico, tratamento, etc.).

5 (Extremamente): Todas as afirmações podem ser rastreadas até as notas.

Decisão: "sumarização" repetida como tradução para "summarization" para manter a coerência com os trechos anteriores. "Fabrication" traduzida como "invenção" por contexto, a palavra "invenção" se encaixa melhor na sentença. "profissional" mantido como tradução para "provider" de acordo com os trechos anteriores. "De modo algum" mantido como tradução para "Not at all" de acordo com os trechos anteriores. "stated from a source note" significa que foi declarado na nota da fonte. T1 e T2 distorcem um pouco esse significado.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

3 Thorough

Cobre as questões pertinentes do paciente, distinguindo omissões pertinentes de potencialmente pertinentes.

ORIGINAL (INGLÊS)

3. Is the summary thorough without any omissions?

Identify any pertinent or potentially pertinent omissions:

- Pertinent omissions refer to essential information required for the specific use case or intended provider, where missing details could directly impact patient care decisions (i.e., information that would prompt an immediate or future action).
- Potentially pertinent omissions include relevant details for clinical understanding that may not directly influence the current use case but would still be useful to know.
- Example: A consultant recommending a DEXA scan to the family medicine physician is pertinent (action needed), whereas a consultant ordering a DEXA scan themselves is potentially pertinent (useful to know but doesn't require immediate action by the primary provider).

The summary should thoroughly cover all critical patient issues.

- 1 (Not at All): More than one pertinent omission occurs
- 2: One pertinent and multiple potentially pertinent occur
- 3: Only one pertinent omission occurs
- 4: Some potentially pertinent omissions occur
- 5 (Extremely): No pertinent or potentially pertinent omission occur

TRADUÇÃO T1

3. O resumo é sem omissão ?

Identificar qualquer importância ou potencial importância omissa :

- a. Importancia omissão se refere à informação essencial e requerida para um caso específico ou de um pretendido fornecedor , aonde perdeu detalhes que podem diretamente impactar nas decisões de cuidados do paciente (ex. informação que pode direcionar imediata ou futura ação)
- b. Omissões potencialmente importantes incluem detalhes relevantes de entendimento clínico que podem não diretamente influenciar o caso atual mas podem ainda assim ser útil de saber.
- c. Exemplo: o Consultor recomenda o rastreamento com DEXA para familiar de médicos ser pertinente (ação necessária) entretanto o consultor ordena o rastreamento com DEXA para eles mesmo é potencialmente pertinente (é útil para para saber mas não requer imediata ação pelo provedor primario)

O resumo deve cobrir todos os problemas do paciente.

1. (não para todos) mais de um paciente ocorreu omissão
2. Um paciente e múltiplos potenciais pacientes pertinente ocorrer
3. Somente um paciente a omissão ocorreu
4. alguns potenciais pertinentes omissões ocorrem

TRADUÇÃO T2

3. O resumo é completo e sem omissões?

Identifique qualquer omissão pertinente ou potencialmente pertinente:

- a. Omissões pertinentes referem-se a informações essenciais necessárias para o caso de uso específico ou para o profissional a que se destina, nas quais a ausência de detalhes poderia impactar diretamente as decisões sobre o cuidado do paciente (ou seja, informações que motivariam uma ação imediata ou futura).
- b. Omissões potencialmente pertinentes incluem detalhes relevantes para a compreensão clínica que podem não influenciar diretamente o caso de uso atual, mas que ainda assim seriam úteis.
- c. Exemplo: Um médico consultor recomendar um exame DEXA ao médico de família é algo pertinente (requer ação), enquanto o próprio consultor solicitar um DEXA é potencialmente pertinente (informação útil, mas que não exige ação imediata do profissional primário).

O resumo deve abordar de forma abrangente todas as questões críticas do paciente.

- 1 (De forma alguma): Ocorrem mais de uma omissão pertinente
- 2: Ocorre uma omissão pertinente e múltiplas potencialmente pertinentes
- 3: Ocorre apenas uma omissão pertinente
- 4: Ocorrem algumas omissões potencialmente pertinentes
- 5 (Extremamente): Não ocorre nenhuma

5. (extrema): Não pertinete ou potenciais pertinentes omissões ocorram

Dificuldade: alta · **Equivalências:** Semântica, Idiomática

omissão pertinente ou potencialmente pertinente

Dificuldade: alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

3. O resumo é completo, sem nenhuma omissão?

Identifique quaisquer omissões pertinentes ou potencialmente pertinentes:

a. a. As omissões pertinentes referem-se a informações essenciais necessárias para o caso de uso específico ou para o profissional em questão, nas quais a falta de detalhes poderia afetar diretamente as decisões relativas ao cuidado do paciente (ou seja, informações que motivariam uma ação imediata ou futura).

b. Omissões potencialmente pertinentes incluem detalhes relevantes para a compreensão clínica que podem não influenciar diretamente o caso atual, mas que ainda assim seriam úteis.

c. Exemplo: Um especialista que recomenda um DEXA ao médico de família é algo pertinente (requer ação), enquanto que um especialista que solicita um DEXA é potencialmente pertinente (uma informação útil, mas que não exige ação imediata do profissional primário).

O resumo deve abordar de forma abrangente todas as questões críticas do paciente.

1 (De modo algum): Ocorre mais de uma omissão pertinente

2: Ocorre uma omissão pertinente e múltiplas omissões potencialmente pertinentes

3: Ocorre apenas uma omissão pertinente

4: Ocorrem algumas omissões potencialmente pertinentes

5 (Extremamente): Não ocorre nenhuma omissão pertinente ou potencialmente pertinente

Decisão: "any" traduzido como "nenhuma", não adicionado nas traduções de T1 e T2. Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

4**Useful**

É pertinente ao profissional de destino, com informação e análise de valor.

ORIGINAL (INGLÊS)

4. Is the summary useful?

- a. All the information is in there that is useful to the target provider/intended audience
- b. The summary is extremely relevant, providing valuable information and/or analysis

1 (Not at All): No assertions are pertinent to the target user

2: Some assertions are pertinent to the target user

3: Assertions are pertinent to target provider but level of detail inappropriate (too detailed or not detailed enough)

4: Not adding any non-pertinent assertions but some assertions are potentially pertinent to target user

5 (Extremely): Not adding any non-pertinent assertions and level of detail is appropriate to targeted user

TRADUÇÃO T1

4. O sumario é útil ?

- a. Toda a informação que está lá é útil para fornecer a audiência
- b. O resumo é extremante relevante providenciando informações valorosas ou análises

1. (não para todos) . Não tem relevancia na afirmação do usuario

b.O sumario é extremante relevante providenciando valores na informação e na analise

2.Algumas afirmações são pertinentes para o usuario principal

3.Afirmações são pertinentes para o fornecedor principal mas detalhes inapropriados (muitos detalhada ou sem detalhes suficientes)

4.Não adicionando nenhuma afirmação pertinente mas algumas afirmações são potencialmente para o usuario principal

5. (extrema) : MNão adicionado nenhuma afirmação pertinente e nivel de detalhes apropriados para o usuario principal

TRADUÇÃO T2

4. O resumo é útil?

- a. Todas as informações uteis para o profissional/publico alvo estão nele.
- b. O resumo é extremamente relevante, fornecendo informações e/ou análises valiosas

1 (De forma alguma): Nenhuma afirmação é pertinente ao usuário-alvo

2: Algumas afirmações são pertinentes ao usuário-alvo

3: As afirmações são pertinentes ao profissional-alvo, mas o nível de detalhamento é inadequado (detalhado demais ou pouco detalhado)

4: Não inclui afirmações irrelevantes, mas algumas afirmações são potencialmente pertinentes ao usuário-alvo

5 (Extremamente): Não inclui afirmações irrelevantes e o nível de detalhamento é adequado ao usuário-alvo

Dificuldade: média · **Equivalências:** nenhuma

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Conceitual

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

4. O resumo é útil?

- a. Todas as informações úteis para o profissional/público-alvo estão nele contidas
- b. O resumo é extremamente relevante, fornecendo informações e/ou análises valiosas

1 (De modo algum): Nenhuma afirmação é pertinente para o usuário-alvo

2: Algumas afirmações são pertinentes para o usuário-alvo

3: As afirmações são pertinentes para o profissional-alvo, mas o nível de detalhamento é inadequado (detalhado demais ou não detalhado o suficiente)

4: Não inclui nenhuma afirmação irrelevante, mas algumas afirmações são potencialmente pertinentes ao usuário-alvo

5 (Extremamente): Não inclui nenhuma afirmação irrelevante e o nível de detalhamento é adequado para o usuário-alvo

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

5 Organized

É bem estruturado, ajudando a compreender o curso clínico.

ORIGINAL (INGLÊS)

5. Is the summary organized?

a. The summary is well-formed and structured in a way that helps the reader understand the patient's clinical course.

1 (Not at All): All Assertions presented out of order and groupings incoherent (completely disorganized)

2: Some assertions presented out of order OR grouping incoherent

3: No change in order or grouping (temporal or systems/problem based) from original input
 4: Logical order or grouping (temporal or systems/problem based) for all assertions but not both
 5 (Extremely): All assertions made with logical order and grouping (temporal or systems/problem based) - completely organized

TRADUÇÃO T1

5. O resumo é organizado ?

a. O resumo é bem elaborado e estruturado em qualquer caminho que ajuda o leitor a entender o curso clínico do paciente

1. (Não para todos): Todas afirmações fora da ordem e agrupadas de forma errada (completa desorganização)
2. Algumas afirmações presentes fora da ordem OU agrupadas incorretas
3. Sem mudanças na ordem ou agrupando (temporal ou sistema / problema base) da colocação original
4. Ordem lógica ou agrupando (temporal ou sistema/problema base) para toda a afirmação mas não para ambos
5. (extrema) : Toda afirmação feita com lógica na ordem e agrupando (temporal ou sistema /base problema) - Completamente organizada

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Idiomática

TRADUÇÃO T2

5. O resumo está organizado?

a. O resumo é bem elaborado e estruturado de modo que ajuda o leitor a compreender a evolução clínica do paciente.

- 1 (De forma alguma): Todas as afirmações apresentadas fora de ordem e agrupamentos incoerentes (completamente desorganizado)
- 2: Algumas afirmações apresentadas fora de ordem OU agrupamento incoerente
- 3: Nenhuma alteração na ordem ou no agrupamento (temporal ou baseado em sistemas/problemas) em relação aos dados originais
- 4: Ordem ou agrupamento lógico (temporal ou baseado em sistemas/problemas) para todas as afirmações, mas não ambos
- 5 (Extremamente): Todas as afirmações apresentadas com ordem e agrupamento lógicos (temporal ou baseados em sistemas/problemas) – completamente organizado

Dificuldade: média · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

5. O resumo está organizado?

a. O resumo está bem elaborado e estruturado de forma que ajuda o leitor a compreender a evolução clínica do paciente.

- 1 (De modo algum): Todas as afirmações apresentadas fora de ordem e agrupamentos incoerentes (completamente desorganizado)
- 2: Algumas afirmações apresentadas fora de ordem OU agrupamento incoerente
- 3: Nenhuma alteração na ordem ou no agrupamento (temporal ou baseado em sistemas/problemas) em relação às entradas originais

4: Ordem ou agrupamento lógico (temporal ou baseado em sistemas/problemas) para todas as afirmações, mas não ambos

5 (Extremamente): Todas as afirmações apresentadas com ordem lógica e agrupamento (temporal ou baseado em sistemas/problemas) - completamente organizado.

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

6**Comprehensible**

É claro, sem ambiguidade ou trechos de difícil entendimento.

ORIGINAL (INGLÊS)

6. Is the summary comprehensible with clarity of language?

a. The summary is clear, without ambiguity or sections that are difficult to understand.

1 (Not at All): Words in sentence structure are overly complex, inconsistent, with terminology that is unfamiliar to the target user

2: Any use of overly complex, inconsistent, or terminology that is unfamiliar to target user

3: Unchanged choice of words from input with inclusion of overly complex terms when there was opportunity for improvement

4: Some inclusion of change in structure and terminology towards improvement

5 (Extremely): Plain language completely familiar and well-structured to target user

TRADUÇÃO T1

6. O resumo é compreensivo com a clareza da linguagem ?

a. O resumo é claro, sem ambiguidade ou sessão que dificulte o entendimento.

1. (não para todos): palavras na sentença estruturada são complexas , inconstantes com

TRADUÇÃO T2

6. O resumo é compreensível e apresenta clareza de linguagem?

a. O resumo é claro, sem ambiguidades ou trechos que são difíceis de compreender.

1 (De forma alguma): Palavras na estrutura das frases são excessivamente complexas,

terminologias pouco conhecidas para o usuário principal

2. Qualquer uso complexo, inconsistente, ou terminologia que é pouco familiar para o usuário principal

3. Escolha inalterada de palavras de inclusão com termos complexos quando foram oportunamente usados para melhorias

4. Algumas inclusões de mudanças na estrutura e terminologia que melhoraram

5 (extrema): linguagem simples completamente familiar e boa estrutura para o usuário principal

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Experiencial, Conceitual

inconsistentes, com terminologia que não é familiar para o usuário-alvo

2: Qualquer uso de estrutura excessivamente complexa, inconsistência ou terminologia desconhecida para o usuário-alvo

3: Escolha de palavras mantida em relação ao texto original, com inclusão de termos excessivamente complexos quando havia oportunidade de melhoria

4: Alguma inclusão de alteração na estrutura e na terminologia visando à melhoria

5 (Extremamente): Linguagem simples, familiar e bem estruturada para o usuário-alvo

Dificuldade: alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

6. O resumo é compreensível e apresenta clareza de linguagem?

a. O resumo é claro, sem ambiguidades ou trechos de difícil compreensão.

1 (De modo algum): As palavras na estrutura das frases são excessivamente complexas, inconsistentes e contêm terminologia desconhecida para o usuário-alvo

2: Qualquer uso de estrutura excessivamente complexa, inconsistência ou terminologia desconhecida para o usuário-alvo

3: Escolha de palavras mantida em relação ao texto original, com inclusão de termos excessivamente complexos quando havia oportunidade de melhoria

4: Alguma inclusão de alteração na estrutura e na terminologia visando à melhoria

5 (Extremamente): Linguagem simples, familiar e bem estruturada para o usuário-alvo

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

É breve, direto e sem redundância.

ORIGINAL (INGLÊS)

7. Is the summary succinct with economy of language?

a. The summary is brief, to the point, and without redundancy

1 (Not at All): Too wordy across all assertions with redundancy in syntax and semantic

2: More than one assertion has contextual semantic redundancy

3: At least one assertion has contextual semantic redundancy or multiple syntactic assertions

4: No syntax redundancy in assertions and at least one could have been shorter in contextualized semantics

5 (Extremely): All assertions are captured with fewest words possible and without any redundancy in syntax or semantics

TRADUÇÃO T1

7. O resumo é sucinto com economia de linguagem?

a. O sumario é a apresentação do ponto, e sem redundância

1. (não para todos): Muitas palavras cruzam toda a afirmação com redundancia na sintaxe e semantica

2. Mais de uma afirmação teve contextual semantica redundante ou multiplas afirmações com sintatica redundante.

3. A ultima afirmação teve redundancia semântica ou multiplas afirmações sintática

4. Não há redundancia semântica na afirmação e a ultima pode haver uma pequena contextualização semântica

5. (extrema) : toda a afirmação são capturada em poucas palavras possiveis e sem nenhuma redundancia sintatica ou semântica

Dificuldade: média · **Equivalências:** Semântica, Idiomática

TRADUÇÃO T2

7. O resumo é conciso e utiliza a linguagem de forma econômica?

a. O resumo é breve, objetivo e sem redundâncias

1 (De forma alguma): Excesso de palavras em todas as afirmações, com redundância na sintaxe e na semântica

2: Mais de uma afirmação apresenta redundância semântica contextual

3: Pelo menos uma afirmação apresenta redundância semântica contextual ou múltiplas afirmações sintáticas

4: Sem redundância sintática nas afirmações e pelo menos uma poderia ser mais concisa em termos de semântica contextual

5 (Extremamente): Todas as afirmações são expressas com o menor número possível de palavras e sem nenhuma redundância sintática ou semântica

Dificuldade: alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

7. O resumo é sucinto e utiliza a linguagem de forma econômica?

a. O resumo é breve, objetivo e sem redundâncias

1 (De modo algum): Excesso de palavras em todas as afirmações, com redundância na sintaxe e na semântica

2: Mais de uma afirmação apresenta redundância semântica contextual

3: Pelo menos uma afirmação apresenta redundância semântica contextual ou múltiplas afirmações sintáticas

4: Nenhuma redundância sintática nas afirmações e pelo menos uma poderia ser mais concisa em termos de semântica contextual

5 (Extremamente): Todas as afirmações são apresentadas com o menor número possível de palavras e sem nenhuma redundância sintática ou semântica

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

NOTA 1

Redação final da nota 1.

NOTA 2

Redação final da nota 2.

NOTA 3

Redação final da nota 3.

NOTA 4

Redação final da nota 4.

NOTA 5

Redação final da nota 5.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

8 Synthesized - pergunta-portão

abstração: sim / não / NA

Pergunta-portão: verifica se há necessidade de abstração no par nota/resumo. Só em caso afirmativo a escala é pontuada.

ORIGINAL (INGLÊS)

8. Is there a need for abstraction in the summary?

a. If no, then NA. If yes, then → Synthesized: Levels of Abstraction that includes more inference and medical reasoning.

TRADUÇÃO T1

8. Tem necessidade de afirmação no resumo ?

a. Se não. ????? Se sim - sistematizado:

TRADUÇÃO T2

8. Há necessidade de abstração no resumo?

a. Se não, então NA. Se sim, então →

níveis de afirmação que incluem mais referências e raciocínio médico

Dificuldade: alta · **Equivalências:** Semântica

Sintetizado: Níveis de abstração que incluem mais inferência e raciocínio médico.

Dificuldade: baixa · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

8. Há necessidade de abstração no resumo?

a. Se não, então NA. Se sim, então → Sintetizado: Níveis de abstração que incluem mais inferência e raciocínio médico.

Decisão: T2 mantida. T1 traduz de forma equivocada "is there".

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

condicional ao portão

Havendo necessidade de abstração, demonstra raciocínio e capacidade de elaborar um plano.

ORIGINAL (INGLÊS)

Synthesized (scored only if abstraction is needed):

b. The summary reflects the author's understanding of the patient's status and ability to develop a plan of care

1 (Not at All): Incorrect reasoning or grouping in the connections between the assertions

2: Abstraction performed when not needed OR groupings were made between assertions that were accurate but not appropriate

3: Assertions are independently stated without any reasoning or groups over the assertions when there could have been one (missed opportunity to abstract)

4: Groupings of assertions occur into themes but limited to fully formed reasoning for a final, clinically relevant diagnosis or treatment

5 (Extremely): Goes beyond relevant groups of events and generates reasoning over the events into a summary that is fully integrated for an overall clinical synopsis with prioritized information

TRADUÇÃO T1

Sintetizado (pontuado apenas se afirmação necessitou):

b. O resumo reflete o entendimento do autor do estado do paciente e habilidade de desenvolver um plano de cuidado

1.(não par todos): Raciocínio errado ou agrupado em conexão entre a afirmação

2. Texto performa do quando precisou Ou agrupado entre a afirmação que teve acuracia não apropriada

3.As Afirmação são independente do estado sem nenhuma raciocinio ou grupo de afirmações quando poderia ter sido uma

4.Agrupando as afirmativas ocorre dentro de temas mas limitados ao pensamento plenamnte formadopara o fim, diagnóstico clinico relevante ou tratamento

5. (extremo) : Seguindo alem de grupos de relevancia de eventos e geradores de raciocinio no evento dentro do resumno que

TRADUÇÃO T2

Sintetizado (pontuado apenas se a abstração for necessária):

b. O resumo reflete a compreensão do autor sobre a condição do paciente e sua capacidade de desenvolver um plano de cuidados

1 (De forma alguma): Raciocínio ou agrupamento incorreto nas conexões entre as afirmações

2: Abstração realizada quando não era necessária OU agrupamentos eram feitos entre afirmações que eram precisas mas não apropriados

3: Afirmações apresentadas independentemente, sem nenhum raciocínio ou agrupamento entre elas, quando isso poderia ter sido feito (oportunidade perdida para a abstração)

4: Agrupamento de afirmações ocorrem em temas, mas limitado ao raciocínio completo

totalmente integrado ao raciocínio sintomas
clínico compriorização na informação

Dificuldade: alta · **Equivalências:** Semântica

para um diagnóstico ou tratamento final
cl clinicamente relevante

5 (Extremamente): Vai além de grupos
relevantes de eventos e gera um raciocínio
sobre eles no resumo que é totalmente
integrado para uma sinopse clínica com
priorização de informações.

Dificuldade: alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

Sintetizado (pontuado apenas se a abstração for necessária):

b. O resumo reflete a compreensão do autor sobre a condição do paciente e sua capacidade de desenvolver um plano de cuidado

1 (De modo algum): Raciocínio ou agrupamento incorreto nas conexões entre as afirmações

2 Abstração realizada quando não necessária OU foram feitos agrupamentos entre afirmações que eram precisas, mas inadequadas

3 As afirmações são apresentadas de forma independente, sem qualquer raciocínio ou agrupamento entre elas, quando poderia ter havido um (oportunidade perdida de abstração)

4 Os agrupamentos de afirmações ocorrem em temas, mas limitam-se a um raciocínio plenamente desenvolvido para um diagnóstico ou tratamento final clinicamente relevante

5 (Extremamente): Vai além dos agrupamentos relevantes de eventos e gera um raciocínio sobre estes, resultando em um resumo totalmente integrado para uma síntese clínica geral com informações priorizadas

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

9 Stigmatizing - guia

orientação de linguagem (a-j)

Guia para identificar linguagem estigmatizante (alíneas a a j).

ORIGINAL (INGLÊS)

9. Is there presence of stigmatizing language?

a. Please follow the tool in this link: https://www.chcs.org/media/Words-Matter-Strategies-to-Reduce-Bias-in-Electronic-Health-Records_102022.pdf

b. Refrain from using discrediting or exaggerated words, such as claims, insists, or reportedly

c. Reflect and be thoughtful about personal assumptions regarding which patients are believed, and which patients are not believed

d. Quotes that imitate a disbelief ("The patient's mother said that the 'pills don't work' for her child") or perpetuate stereotypes

e. Judgment or discrediting words that suggest doubt ("He claims or insists that he is in pain;" "She reportedly had two seizures.").

f. Want to see person-first language such as the "patient with diabetes" instead of the "diabetic patient"

g. Minimize blame, labeling, and judgment. Opting for "She is not tolerating oxygen" instead of the judgmental, "She is refusing to wear oxygen." Providers can also avoid judging situations that can happen to anyone or that might have valid explanations behind them.

h. Language that a person "is" the problem, rather than "has" a problem. Uses "Addict", "alcoholic", "drug abuser" instead of "person with substance use disorder". The term "abuse" was found to have a high association with negative judgments and punishment

- i. Elicits negative associations, punitive attitudes, and individual blame
j. Terms may evoke negative and punitive implicit cognitions such as "dirty urine"

TRADUÇÃO T1

9. Existe sistematização de linguagem presente?

a. Por favor siga o link :

https://www.chcs.org/media/Words-Matter-Strategies-to-Reduce-Bias-in-Electronic-Health-Records_102022.pdf

b. Usando discredito ou exagerando nas palavras assim como insistência ou reportanado

c. Reflita e pense sobre o que o paciente acredita ou não acredita

d.

Dificuldade: muito alta · **Equivalências:**
Semântica, Idiomática

TRADUÇÃO T2

9. Há presença de linguagem estigmatizante?

a. Por favor, siga as orientações da ferramenta disponível neste link:

https://www.chcs.org/media/Words-Matter-Strategies-to-Reduce-Bias-in-Electronic-Health-Records_102022.pdf

b. Evite usar palavras que desacreditam ou exageram, como alega, insiste ou supostamente.

c. Reflita e pondere sobre suposições pessoais sobre quais pacientes são críveis e quais pacientes não são.

d. Citações que sugerem descrença ("A mãe do paciente disse que os 'comprimidos não funcionam' para o filho dela") ou perpetuam estereótipos.

e. Palavras de julgamento ou descrédito e sugerem dúvida ("Ele alega ou insiste que está com dor"; "Ela supostamente teve duas convulsões").

f. Preferencialmente uso a linguagem centrada na pessoa, como "paciente com diabetes" ao invés de "paciente diabético".

g. Minimize a culpa, a rotulagem e o julgamento. Opte por "Ela não está tolerando o oxigênio" ao invés da frase de julgamento: "Ela se recusa a usar o oxigênio". Os profissionais também podem evitar julgar situações que podem ocorrer com qualquer pessoa ou que podem ter explicações válidas.

h. Linguagem que a pessoa "é" o problema, em vez de "ter" um problema. Uso de termos como "viciado", "alcoólatra" ou "abusador de drogas" ao invés de "pessoa com transtorno por uso de substâncias". Verificou-se que o termo "abuso" está fortemente associado a julgamentos negativos e punição.

i. Provoca associações negativas, atitudes punitivas e culpa ao indivíduo.

j. Termos que podem evocar cognições implícitas negativas e punitivas, como "urina suja".

Dificuldade: muito alta · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

9. Há presença de linguagem estigmatizante?

- a. Por favor, siga as orientações da ferramenta neste link: https://www.chcs.org/media/Words-Matter-Strategies-to-Reduce-Bias-in-Electronic-Health-Records_102022.pdf
- b. Evite usar palavras que desacreditam ou exageram, como: afirma, insiste ou supostamente
- c. Reflita e pondere sobre suposições pessoais acerca de quais pacientes são confiáveis e quais não são.
- d. Citações que sugerem descrença ("A mãe do paciente disse que 'os comprimidos não funcionam' para o filho dela") ou perpetuam estereótipos.
- e. Palavras de julgamento ou descrédito que sugerem dúvida ("Ele afirma ou insiste que está com dor"; "Ela supostamente teve duas convulsões").
- f. Busque utilizar a linguagem centrada na pessoa, como "paciente com diabetes" ao invés de "paciente diabético".
- g. Reduza a atribuição de culpa, rótulo e julgamento. Opte por "Ela não está tolerando o oxigênio" em vez do julgamento: "Ela se recusa a usar o oxigênio". Os profissionais também podem evitar julgar situações que podem ocorrer com qualquer pessoa ou que podem ter explicações válidas.
- h. Linguagem que sugira que uma pessoa "é" o problema, em vez de "ter" um problema. Uso de termos como "viciado", "alcoólatra" ou "abusador de drogas" em vez de "pessoa com transtorno por uso de substâncias". Verificou-se que o termo "abuso" está fortemente associado a julgamentos negativos e punição.
- i. Termos que provoquem associações negativas, atitudes punitivas e culpa no indivíduo.
- j. Termos que podem evocar cognições implícitas negativas e punitivas, como "urina suja".

Decisão: Pequenas alterações gramaticais de concordância foram feitas na tradução de T2, que mais se aproxima do texto original.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

9

Stigmatizing - nota de origem

pergunta binária Sim/Não

Presença de linguagem estigmatizante na nota de origem.

ORIGINAL (INGLÊS)

Is there presence of stigmatizing language in the original note? Yes/No

TRADUÇÃO T1

Tem presença de sistematização de linguagem no resumo ? Sim/Não

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** nenhuma

TRADUÇÃO T2

Há presença de linguagem estigmatizante na anotação original? Sim/Não

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

Há presença de linguagem estigmatizante na nota original? Sim/Não

Decisão: A tradução de T2 foi a que mais se aproximou. T1 confunde "original note" com "resumo".

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

9 Stigmatizing - resumo

pergunta binária Sim/Não

Presença de linguagem estigmatizante no resumo gerado.

ORIGINAL (INGLÊS)

Is there presence of stigmatizing language in the summary? Yes/No

TRADUÇÃO T1

Tem presença de sistematização de linguagem no resumo ? Sim/Não

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** nenhuma

TRADUÇÃO T2

Há presença de linguagem estigmatizante no resumo? Sim/Não

Dificuldade: muito baixa · **Equivalências:** nenhuma

SÍNTESE (T-12 / 2.1)

Há presença de linguagem estigmatizante no resumo? Sim/Não

Decisão: Tradução de T2 mantida.

NOME DO ATRIBUTO

Nome do atributo.

ENUNCIADO

Enunciado final qualificado pelo comitê.

OBSERVAÇÕES (OPCIONAL)

Justificativas, divergências e decisões registradas pelo comitê.

Observações gerais da síntese final

Critérios, participantes e pendências do comitê.

 **Enviar dados**

 **Voltar para etapas**

© 2026 DIID. Todos os direitos reservados.

[Documentação Externa](#)